

CAPÍTULO 8.18

Patología Perianal

PERFIL EUNACOM 1.06.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Trauma Abdominal y Torácico

Principio General

TABLA 8.18.1: TIPO DE TRAUMA VS HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA CLAVE	
TIPO DE TRAUMA	HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA CLAVE
Trauma abdominal cerrado	Clínica + ECO FAST
Trauma abdominal por arma blanca	Clínica + exploración digital de la herida
Trauma abdominal por arma de fuego	Cirugía directa (indicación absoluta)
Trauma torácico cerrado	Clínica + Radiografía de tórax
Trauma torácico por arma blanca	Igual a trauma torácico cerrado
Trauma torácico por arma de fuego	Cirugía directa

EUNACOM CRITERIOS

Regla universal de los balazos: un disparo en el abdomen o en el tórax = **cirugía** siempre, sin excepción.

Trauma Abdominal Cerrado

Manejo

- Evaluación clínica (signos vitales, examen abdominal)
- ECO FAST** (Focused Assessment with Sonography for Trauma)
- Busca: líquido libre, signos de hemorragia, neumoperitoneo

Conducta

TABLA 8.18.2: SITUACIÓN VS DECISIÓN	
SITUACIÓN	DECISIÓN
Signos vitales normales + ECO FAST normal	Observación
Hemodinamia inestable	Exploración quirúrgica urgente
Signos peritoneales (Blumberg, rigidez, abdomen en tabla)	Exploración quirúrgica urgente
ECO FAST con líquido libre	Exploración quirúrgica urgente

NOTA CLÍNICA

El lavado peritoneal diagnóstico está obsoleto. Hoy manda la clínica + ECO FAST.

Viscera Hueca vs. Viscera Sólida

TABLA 8.18.3: LESIÓN VS CLÍNICA		
LESIÓN	CLÍNICA	ECO
Viscera hueca (intestino, estómago)	Peritonitis difusa grave + neumoperitoneo	Aire + líquido libre
Viscera sólida (hígado, bazo, riñón)	Hemorragia → hemodinamia inestable	Líquido libre (sangre) sin aire

Trauma Abdominal por Arma Blanca

- Examen: clínica + **exploración digital** de la herida (¿penetra la fascia?)
- Si penetra peritoneo → exploración quirúrgica

- Si no penetra → observación

Trauma Abdominal por Arma de Fuego

- Cirugía siempre** (independiente de la clínica o estudios)

Trauma Torácico Cerrado

Manejo

- Soporte respiratorio: oxígeno, ventilación si es necesario
- Radiografía de tórax** (examen de elección)
- Manejo de complicaciones

Complicaciones

TABLA 8.18.4: COMPLICACIÓN VS CLÍNICA		
COMPLICACIÓN	CLÍNICA	TRATAMIENTO
Neumotórax	Murmulo vesicular abolido + timpanismo	Tubo pleural
Neumotórax a tensión	Desviación de tráquea + ingurgitación yugular + colapso hemodinámico	Punción descompresiva urgente (aguja) → tubo pleural
Hemotórax	Murmulo vesicular abolido + matidez	Tubo pleural
Hemotórax masivo	Flujo > 1.500 mL inicial o > 200 mL/h	Tubo pleural → si persiste: toracotomía
Contusión pulmonar	Infiltrados en Rx, sin clínica de neumotórax	Soporte (O ₂ y ventilación)

Trauma Torácico por Arma Blanca

- Manejo igual al trauma cerrado: clínica + Rx de tórax
- Las complicaciones se manejan igual (tubo pleural, etc.)

Trauma Torácico por Arma de Fuego

- Cirugía siempre** (mismo principio que abdomen)

Tórax Inestable (Volet Costal)

- Definición:** fractura de 3 o más costillas consecutivas en 2 o más puntos → segmento flotante
- Clínica:** respiración paradójica (el segmento roto se hunde al inspirar y sale al espirar)
- Tratamiento:** soporte ventilatorio (ventilación mecánica en casos graves)

Resumen Toma de Decisión Rápida

''' Trauma abdominal |— Cerrado → ECO FAST | |— Normal + hemoestable → Observar | |— Líquido / signos peritoneales / hemodinamia inestable → Cirugía |— Arma blanca → Exploración digital | |— No penetra → Observar | |— Penetra → Cirugía |— Arma de fuego → Cirugía SIEMPRE

Trauma torácico |— Cerrado / Arma blanca → Rx tórax → manejar complicaciones |— Arma de fuego → Cirugía SIEMPRE '''

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 35 años consulta por dolor anal punzante y desgarrador de gran intensidad durante y después de la defecación, de 2 meses de duración, que dura varias horas post-evacuación y se acompaña de estrías de sangre roja fresca en el papel higiénico. Examen proctológico revela úlcera longitudinal en línea media posterior anal con pliegue centinela en el margen externo."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Fisura Anal Crónica: desgarro del anodermo distal a la línea dentada, predominantemente en la línea media posterior (90%). El dolor postdefecatorio prolongado se debe al hipertono del esfínter anal interno. Manejo de primera línea: Dieta rica en fibra y agua + Baños de asiento tibios + Relajantes del esfínter anal tópicos (Diltiazem al 2% o Nitroglicerina tópica) por 6-8 semanas. En casos refractarios: Toxina botulínica o Esfinterotomía Lateral Interna quirúrgica.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- No confundir fisura anal con fístula anal: son enfermedades distintas con manejos diferentes
- El tratamiento de la fisura anal (aguda y crónica) son los baños de asiento; la cirugía (esfinterotomía del esfínter interno) es solo si no responde
- El hemorroide externo trombosado es violáceo y está fuera del ano; la fluxión hemorroidal es más dolorosa y protruye desde adentro
- Los hemorroides internos sangran pero no duelen; requieren colonoscopia para descartar otras causas de hemorragia digestiva baja
- El absceso perianal es eritematoso y fluctuante; se trata con drenaje quirúrgico en pabellón, sin antibióticos
- La fístula anal requiere cirugía con remoción del trayecto fistuloso para evitar recurrencia
- El absceso pelvirectal presenta compromiso sistémico, requiere imagen (RMN) y antibióticos (ceftriaxona + metronidazol) además del drenaje
- El diagnóstico diferencial del absceso pelvirectal incluye la prostatitis aguda

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA PERIANAL)**PREGUNTA 1**

Hombre de 45 años consulta por dolor anal intenso de inicio súbito, que aumenta al sentarse. Al examen se palpa nódulo violáceo, doloroso, en la zona perianal externa. El cuadro lleva 24 horas de evolución. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Drenaje quirúrgico en pabellón
- B)** Baños de asiento y eventualmente trombectomía
- C)** Esfinterotomía del esfínter anal interno
- D)** Ligadura de hemorroides
- E)** Antibióticos orales y observación

PREGUNTA 2

Paciente de 32 años con antecedente de constipación crónica consulta por dolor anal que aparece con cada defecación, asociado a escasa rectorragia que mancha el papel. Los síntomas llevan 8 semanas de evolución y no han respondido a baños de asiento. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado?

- A)** Ligadura de hemorroides
- B)** Drenaje quirúrgico del absceso
- C)** Baños de asiento más laxantes (polietilenglicol)
- D)** Esfinterotomía del esfínter externo
- E)** Antibióticos orales

PREGUNTA 3

Hombre de 50 años consulta por aumento de volumen perianal doloroso, progresivo, de 5 días de evolución. Al examen se observa lesión eritematosa, fluctuante, en la zona perianal. Temperatura axilar 37.2°C. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Baños de asiento y antibióticos orales
- B)** Trombectomía en box de urgencia
- C)** Drenaje quirúrgico en pabellón
- D)** Observación y control en 48 horas
- E)** Colonoscopia diagnóstica

RESUMEN: PATOLOGÍA PERIANAL

Clase dedicada a la patología perianal, tema frecuente en el EUNACOM con dos a tres preguntas habituales. Se revisan la fisura anal aguda y crónica, los hemorroides externos trombosados e internos, la fluxión hemorroidal, el absceso perianal, la fístula anal y el absceso pelvirectal. La fisura anal aguda se presenta con dolor anal durante la defecación, rectorragia escasa y contracción tónica del esfínter anal interno; se trata con baños de asiento y manejo de la constipación. La fisura crónica tiene la misma clínica pero dura más de seis semanas o recurre, y puede requerir esfinterotomía del esfínter interno si no responde al tratamiento médico. Los hemorroides externos trombosados producen dolor anal agudo con nódulo violáceo perianal y se manejan con baños de asiento y eventualmente trombectomía antes de 72 horas. Los hemorroides internos se manifiestan con hematoquecia indolora y requieren cirugía electiva con ligadura. La fluxión hemorroidal es la patología más dolorosa de la zona anal y generalmente requiere cirugía. El absceso perianal es eritematoso, fluctuante y se trata con drenaje quirúrgico en pabellón sin necesidad de antibióticos. La fístula anal es su complicación y requiere cirugía para drenar el absceso y remover el trayecto fistuloso. El absceso pelvirectal es más grave, presenta compromiso sistémico, requiere imagen preoperatoria y tratamiento con drenaje quirúrgico más ceftriaxona y metronidazol.